

OSTEOMIELITA ACUTĂ ȘI CRONICĂ

- osteomielita acută hematogenă este o boală caracteristică organismului în creștere;
- infirmitățile și supurațiile cronice survin într-un procent de 25% din cazuri;
- afectează copiii din perioada neonatală până la adolescență.

Istoric:

- Launelougne în secolul trecut, apoi Broca, au lansat teoria mielitei (de unde și denumirea bolii) conform căreia infecția localizată metafizar se întinde rapid în canalul medular;
- ulterior Trueta prin studii asupra vascularizației osului la diferite vârste a permis elucidarea înțelegerii procesului fiziopatologic al acestei boli.

Etiopatogenie:

- agentul etiologic este stafilococul aureus în peste 95% din cazuri;
- sexul masculin este mai frecvent afectat;
- tibia și femurul reprezintă sediu preferat al bolii în peste 75% din cazuri;
- punctul inițial de plecare a infecției este sistemul venos a metafizelor osoase;
- germenii ajung la os pe cale sanguină;
- poarta de intrare în organism poate fi aparentă (stafilococia cutanată, furuncule, plăgi infectate) sau inaparentă;
- se produce o invazie microbiană masivă;
- urmează apoi ruperea echilibrului dintre mijloacele de apărare ale organismului și virulența microbiană exacerbată local, în sinusurile venoase ale osului afectat;
- traumatismul, stările de oboseală, de epuizare fizică contribuie la ruperea acestui echilibru labil

Fiziopatologie:

- osteomielita acută evoluează **obligatoriu** în două faze succesive:

1. faza infecției generale:

- din focarul de infecție germenii în exces se revarsă în circulația generală împreună cu toxinele lor;
- apare sepsa cu frisoane și febră, delir și prostrație;
- germenii reținuți în număr mare în capilarele sinusoidale își exacerbează virulența;
- prin toxinele eliminate determină tromboze vasculare și se produce necroza;
- în 3-4 zile circulația osoasă este întreruptă în mare parte prin extinderea trombozelor;
- exudatul masiv și precoce ajunge la suprafața osului în dreptul metafizei, unde corticala este mai subțire și decolează periostul;
- odată cu decolarea periostului se întrerupe și ultima sursă de vascularizație a osului;
- periostul detașat și îndepărtat de corticală își continuă activitatea osteoformatoare.

2. faza delimitării unui abces cu origine osoasă:

- în faza de abces constituit focarul este închis, germenii își pierd din virulență dar își păstrează posibilitatea de multiplicare;
- mijloacele de apărare imunitare ca și antibioticele administrate, devin inoperante, din cauză ca nu mai pot ajunge în focar;
- după 3-4 zile de la debut odată cu constituirea abcesului, șansele de vindecare „ad integrum” chiar cu un tratament combinat medical și chirurgical scad foarte mult.

Clinic:

➤ tabloul clinic este diferit la copil față de sugar:

1. la copil:

- debutul durerii este brusc, adeseori cu precizarea orei când a început durerea;
- localizare aproape de genunchi sau departe de cot, cu sediu metafizar, în majoritatea cazurilor;
- durerea este continuă, foarte intensă, exacerbată la mișcări;
- febră 39°-40°C, aproape continuă, poate fi precedată de frison;
- eventuală poartă de intrare – plagă infectată, furuncul, etc;
- după 2-3 zile urmează perioada de stare în care durerea este continuă, membrul afectat este imobil în poziție antalgică, febra se menține cu oscilații între 38°-40°C;
- local apare edemul, roșeață, căldură locală, venectazii;
- *adenopatia regională lipsește în toate cazurile;*
- după 4-7 zile zona edemațiată devine fluctuantă atestând constituirea abcesului osteomielitic;
- radiologic nu se observă modificări osoase în faza de debut și de stare a bolii;
- biologic: leucocitoză marcată - 20.000/mm³, VSH de 60-120 mm/h, hemocultura cu antibiogramă este pozitivă în cca. 60% din cazuri.

➤ *2. la sugari:*

- epifizele fiind cartilaginoase, vasele sanguine metafizare traversează această zonă și în consecință abcesul care se formează invadează articulația adiacentă;
- periostul bogat vascularizat are o mare putere de osteogeneză, aderă mai puțin la os, se detașează mai ușor și pe suprafețe mari, când se formează abcesul;
- în perioada de debut și chiar în cea de stare, febra rămâne sub 39°C, mai ales la prematuri și sugari tarați;
- imobilitatea și edemul membrului afectat;
- artritele de vecinătate sunt frecvente;
- după 7-10 zile radiografia arată decalcifieri cu zone porotice diseminate metafizar și reacție osteogenică lamelară a periostului detașat;
- în evoluție pot surveni, în funcție de localizare, luxația capului femural din articulația șoldului ca și decolări epifizare, urmate de siderări ale cartilajului de creștere cu sechele definitive.

Complicații:

➤ la copil:

- complicația cea mai frecventă în perioada de stare este bronhopneumonia stafilococică ± piopneumotorace, complicație ce poate deveni mortală;
- pericardita purulentă;
- fracturile pe os patologic se produc ușor și frecvent după reluarea mersului.

➤ la sugar:

- artrita purulentă;
- decolări epifizare cu scurtarea membrului;
- luxația capului femural;
- osteomielita cu localizări multiple

Diagnostic:

- clinic este ușor de stabilit în perioada de stare cu abces constituit;
- **faza incipientă a bolii** este dominată de 2 simptome capitale: **febra și durerea locală, cu sau fără edem;**
- traumatismul - poate avea un rol favorizant în declanșarea osteomielitei;
- depistarea sursei de infecție;
- examenul radiologic:
- nu are valoare în primele 2 săptămâni de boală;
- ulterior relevă decalcifieri osoase în metafiză cu zone porotice și detașarea periostului cu apozitie osoasă;
- după 2-3 luni se pot delimita sechestre osoase, care prin abcedare ajung la fistulizări trenante.



Oteomielită acută metafiză distală tibie – aspect radiologic.

Diagnostic diferențial:

- cu diverse traumatisme (sinovită, entorsă);
- cu fracturile – au alte semne și mai ales nu se însoțesc de febră;
- reumatismul articular acut – edemul și durerea sunt strict articulare;
- artrite în contextul unor boli infecto-contagioase (scarlatina);
- reticulosarcom Ewing;
- metastaze osoase (neuroblastom).

Tratament:

➤ *medical:*

- ca eficiență depinde de precocitatea instituirii lui;
- antibioticele trebuie administrate în faza incipientă, înainte ca trombozele arteriale să se constituie, pentru a ajunge în focar;
- se administrează penicilină (1.000.000 UI/Kg corp/zi), oxacilină (50-100 mg/kg corp/zi), cefalosporine, gentamicină, lyncomicină, tobramicină, rifampicină pentru 7-10 zile sau mai mult, în dublă sau triplă asociere în funcție de antibiogramă.

➤ *ortopedic:*

- constă în imobilizare pe atelă gipsată posterioară care să depășească trebuie continuată în funcție de gravitatea situației timp de 1-3 ambele articulații ale osului afectat;
- imobilizarea gipsată luni sau chiar mai mult, dacă survin alte complicații ca sechestre sau fracturi.

➤ *chirurgical:*

- obligatoriu la toate cazurile cu abces constituit:
- la 7-10 zile de la apariția bolii;
- incizie largă care să permită evacuarea digitală minuțioasă a puroiului circular și pe toată întinderea abcesului;
- focarul va fi drenat cu tub despicat longitudinal.
- postoperator se imobilizare pe atelă gipsată posterioară și antibioterapia până când leucocitoza și VSH-ul arată tendința de normalizare (3-6 săptămâni iar în cazuri grave și cu complicații pulmonare chiar mai mult).

➤ **Evoluție, prognostic:**

- cazurile surprinse aproape de debut (24-48 ore) și tratate corect se vindecă fără complicații;
- la cazurile la care terapia este instituită după acest interval local se constituie un abces ± complicațiile descrise;
- poate evolua spre cronicizare cu pusee de reacutizare chiar la intervale de ani de zile și sechele infirmizante.

➤ **ABCESUL BRODIE**

- este o formă cronică de osteomielită;
- sediul abcesului osos este de obicei la nivelul tibiei, femurului, humerusului;
- clinic – durere vie, nocturnă;
- radiologic – cavitate clară, regulată, delimitată de un contur de condensare osoasă fără reacție periostică, fără implicarea cartilajului;
- trebuie diferențiat de chistul osos, tumora cu mieloplaxă, osteita fibroasă, tuberculoză, sifilisul osos, granulomul eozinofil;
- tratamentul constă în trepanație și chiuretajul cavității, administrare locală de antibiotice.